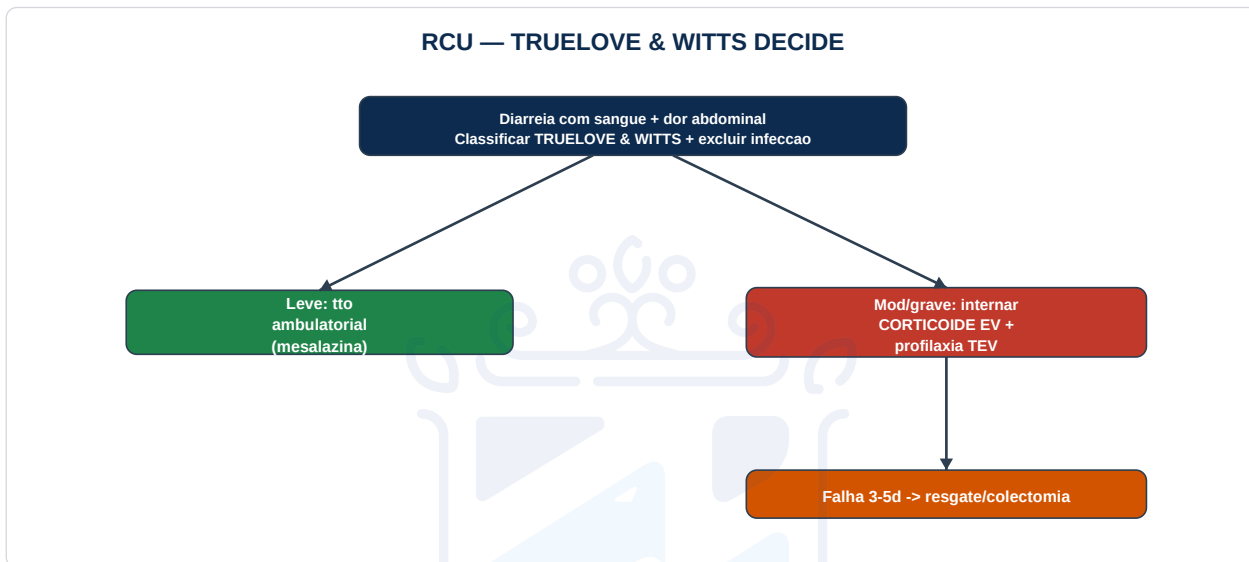


## RETOCOLITE ULCERATIVA — AGUDIZAÇÃO

### FLUXOGRAMA — AGUDIZAÇÃO



### DEFINIÇÃO

#### O QUE É

- Doença inflamatória intestinal crônica, imunomediada, com inflamação CONTÍNUA da MUCOSA do cólon
- Inicia no reto e estende-se proximalmente de forma variável
- Agudizações moderadas/gravas = emergências clínicas (megacólon, hemorragia, colectomia)
- Gatilhos: suspensão/uso irregular da manutenção, infecção (C. difficile, CMV), AINE, falha prévia

### TRUELOVE & WITTS — GRAVIDADE

| Critério            | Leve         | Grave          |
|---------------------|--------------|----------------|
| Evacuações/dia      | < 4          | > 6 com sangue |
| Sangramento retal   | Ausente/leve | Importante     |
| Febre               | Ausente      | > 37,8 C       |
| Frequência cardíaca | < 90 bpm     | > 90 bpm       |
| Hemoglobina         | > 11,5 g/dL  | < 10,5 g/dL    |
| VHS / PCR           | Normal       | Elevado        |

## RED FLAGS — RCU GRAVE E MEGACÓLON

### EMERGÊNCIA CLÍNICA

- RCU grave (Truelove & Witts) é emergência — internar para tratamento intensivo
- Megacólon tóxico: dilatação colônica  $\geq 6$  cm em RX + febre, taquicardia, leucocitose, toxemia
- Megacólon é causa frequente de COLECTOMIA de urgência na RCU
- Conduta no megacólon: jejum, corticoide EV, ATB amplo espectro, monitorização intensiva, cirurgia precoce
- Colectomia de urgência: perfuração, hemorragia maciça, choque séptico, sem resposta em 48-72h

## AVALIAÇÃO E EXAMES

### NO PS

- Checklist: instabilidade hemodinâmica, quantificar evacuações/sangramento, dor/distensão
- Suspende dieta oral em casos moderados/graves; EXCLUIR infecção associada
- Hemograma, PCR, VHS, função renal, eletrólitos, albumina
- Coprocultura + toxina para *C. difficile*; pesquisa de CMV se refratariedade
- RX de abdome se suspeita de megacólon; TC se dúvida diagnóstica/complicações

## TRATAMENTO DA AGUDIZAÇÃO (mod/grave)

### Rx CORTICOIDE EV + MEDIDAS

1a linha: Hidrocortisona 100mg EV 6/6h OU Metilprednisolona 60mg EV 1x/dia  
Avaliar resposta em 72-96h (menos evacuações, menos sangramento, melhora inflamatória)  
Hidratação venosa + correção eletrolítica  
PROFILAXIA de TEV com HBPM (risco trombótico aumentado na DII em atividade)  
Suspende antidiarreicos; EVITAR opioides e AINEs (risco de megacólon)

## REFRATARIEDADE AO CORTICOIDE

### FALHA EM 3-5 DIAS

- Ausência de melhora após 3-5 dias de corticoide EV = refratariedade
- Reavaliar diagnóstico e EXCLUIR infecção (*C. difficile*, CMV)
- Terapia de resgate: anti-TNF infliximabe (preferencial intra-hospitalar)
- Alternativas: tofacitinibe (atenção ao risco trombótico), vedolizumabe (uso mais tardio)
- Avaliação CIRÚRGICA precoce (colectomia) — decisão compartilhada com especialista

## INTERNAÇÃO x ALTA

### DECISÃO

- ☐ INTERNAR: RCU moderada/grave (Truelove), necessidade de corticoide EV, complicações, refratariedade
- ☐ ALTA: evacuações  $< 4$ /dia e sem sangue significativo, dor controlada, via oral tolerada
- ☐ ALTA: plano de manutenção definido + seguimento gastroenterológico garantido
- ☐ Reforçar adesão à manutenção (mesalazina/biológico) e evitar AINE
- ☐ Retorno se: aumento das evacuações/sangramento, febre, distensão, dor intensa

## MODELO DE ENCAMINHAMENTO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- RCU em atividade (Truelove: \_\_\_\_). Evacuações/dia: \_\_\_\_; sangramento: leve/moderado/intenso; Hb \_\_\_\_; PCR \_\_\_\_.
- Condutas: corticoide EV \_\_\_\_; profilaxia de TEV; exclusão de infecção.
- Complicações: megacólon / perfuração / hemorragia. Imagem: \_\_\_\_.
- Motivo da transferência: refratariedade ao corticoide / megacólon tóxico / avaliação cirúrgica.



SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com RCU, > 6 evacuações/dia com sangue, febre 38, FC 100, Hb 9,5, PCR alta. Classificação e conduta?

- A) Leve — tratamento ambulatorial com mesalazina
- B) Grave (Truelove & Witts) — internação e corticoide endovenoso, com profilaxia de TEV e exclusão de infecção
- C) Apenas antidiarreico
- D) Alta com analgésico opioide
- E) Observação domiciliar

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que se indica profilaxia de tromboembolismo venoso (HBPM) na RCU grave internada?

- A) Porque a HBPM trata a inflamação intestinal
- B) Porque a DII em atividade aumenta o risco trombótico
- C) Porque substitui o corticoide
- D) Porque reduz o número de evacuações
- E) Porque previne megacólon

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a principal complicação que leva à colectomia de urgência na RCU?

- A) Síndrome do intestino irritável
- B) Megacólon tóxico
- C) Constipação
- D) Refluxo gastroesofágico
- E) Hemorroidas

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Após 3-5 dias de corticoide EV sem resposta na RCU grave, qual a terapia de resgate preferencial intra-hospitalar?

- A) Mesalazina oral
- B) Infliximabe (anti-TNF), após excluir infecção, com avaliação cirúrgica
- C) Loperamida
- D) Aumentar a dieta
- E) Antibiótico oral isolado

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quais medicamentos devem ser EVITADOS na RCU em atividade grave?

- A) Corticoides
- B) Antidiarreicos e opioides (risco de megacólon) e AINEs
- C) Inibidores de bomba de prótons
- D) Reposição de eletrólitos
- E) Heparina de baixo peso molecular

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Os parâmetros (>6 evacuações com sangue, febre, FC>90, Hb<10,5, PCR alta) configuram RCU grave por Truelove & Witts — emergência: internação, corticoide EV, profilaxia de TEV e exclusão de infecção (*C. difficile*/CMV).

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

A DII em atividade é estado pró-trombótico; por isso indica-se profilaxia de TEV com HBPM no paciente internado, mesmo havendo sangramento intestinal (o risco trombótico supera o de sangramento na maioria).

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

O megacólon tóxico é a principal complicação que leva à colectomia de urgência na RCU: dilatação  $\geq 6$  cm com toxemia, alto risco de perfuração.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

Na RCU grave corticorrefratária (3-5 dias), a terapia de resgate intra-hospitalar preferencial é o infliximabe (anti-TNF), após excluir infecção, sempre com avaliação cirúrgica em paralelo.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

Evitam-se antidiarreicos e opioides (precipitam megacólon tóxico) e AINEs (agravam a atividade) na RCU grave. Corticoide, eletrólitos e HBPM fazem parte do tratamento.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico